

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Publicação 10/10/2025	Numeração SES.DGE/DAP nº 63	Versão nº 01	Páginas 06	Anexos 00
Nome do Procedimento: Como Realizar a Técnica de Curativo em Lesões Abertas				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul				
Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Unidades Básicas de Saúde da Família				
Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Auxiliares/Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros (as).				
Objetivo(s): Realizar a técnica de curativo de forma adequada, promovendo condições favoráveis à cicatrização da lesão, por meio da remoção de fatores que possam retardar esse processo. Visa-se, ainda, a prevenção de infecções cruzadas, garantindo a segurança do paciente por meio da aplicação correta de técnicas e procedimentos padronizados.				
Recursos necessários: Sala (espaço físico), maca ou cadeira, carrinho ou mesa auxiliar, pia com água, sabão, luva de procedimento, gases estéreis, soro fisiológico, seringa de 20ml, agulha 40x12, atadura de crepom, tesoura limpa, solução de Polihexametileno Biguanida (PHMB), pinças estéreis, lixeira com saco branco, Bacia/cuba, se necessário, lâmina de bisturi (se necessário); EPI (óculos, avental e máscara). Esparradrapo; Soluções, medicamentos e/ou coberturas conforme avaliação/prescrição de enfermagem; Computador com prontuário eletrônico para registro.				

CONCEITO

O Procedimento Operacional Padrão (POP) para a realização da técnica de curativo em lesões abertas (ferida, escoriações, etc.) estabelece as etapas sistematizadas para a limpeza e cobertura de feridas, visando promover a cicatrização, prevenir infecções e proteger a área lesionada contra agentes externos. A técnica deve ser realizada conforme as características específicas da ferida, considerando sua localização, tipo de exsudato e sinais de infecção, garantindo assim o manejo adequado e seguro, viabilizando o processo de cicatrização.

O POP orienta a avaliação cuidadosa da lesão e a escolha dos materiais e procedimentos corretos, com base no conhecimento sobre a fisiopatologia das feridas e as fases de cicatrização. A execução do curativo inclui a higienização da área, a aplicação de antissépticos e coberturas apropriadas, além dos cuidados pós-procedimento. A



técnica deve ser realizada por profissionais habilitados, sob prescrição médica ou de enfermagem, assegurando uma prática segura e eficaz, com orientações claras ao paciente sobre cuidados e sinais de complicações.

Execução do Procedimento

Passo 01. Avaliação do Paciente:

Antes de iniciar o procedimento, é essencial realizar uma avaliação abrangente:

1. **Histórico Clínico:** Investigar doenças pré-existentes, medicações em uso e alergias;
2. **Exame Físico:** Avaliar a lesão quanto à localização, tamanho, profundidade, presença de infecção e condições da pele ao redor.

Passo 02. Procedimento (curativo)

1. Preparo do Ambiente e do paciente:

O profissional de saúde deverá:

- Assegurar que o ambiente esteja limpo e confortável;
- Identificar o usuário perguntando seu nome completo;
- Explicar o procedimento ao usuário e obter seu consentimento verbal;
- Posicionar o usuário em maca ou cadeira de forma confortável;
- Conferir a prescrição médica ou do enfermeiro;
- Reunir o material indicado para o curativo;
- Garantir privacidade ao usuário, usando cortinas ou biombo.

2. Higienização das Mãos - Conforme Manual de Biossegurança (disponível no Processo SEI nº [23.0.177095-2](#)).

3. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Colocar avental, máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento.

4. Remoção de curativos anteriores:

- Se houver curativo anterior, umedecer a cobertura com soro fisiológico para facilitar a retirada e preservar o processo de angiogênese;
- Remover cuidadosamente o curativo anterior, utilizando pinça se necessário (considerar que a pinça está contaminada após uso de retirada do curativo). Para continuar o curativo deverá ter outra pinça disponível;
- Observar a ferida com relação ao aspecto da lesão, tamanho, exsudato, pele ao redor e presença de edema, hiperemia, calor ou dor local e odor;
- Trocar as luvas de procedimento antes da próxima etapa.

5. Limpeza da lesão:

- Preparar seringa de 20 ml acoplada à agulha 40x12 ou 25x12mm;



- Aspirar soro fisiológico em temperatura ambiente ou morno (36-37°C). Obs.: A literatura recomenda o uso de volume em abundância, entre 50 a 100 ml por cm²;
- Limpe o leito da ferida de acordo com **Quadro 01** (se jato ou fricção) quantas vezes forem necessárias para retirada de tecido desvitalizado e/ou conteúdos secretivos;
- Se indicado, realizar desbridamento para remoção de tecidos desvitalizados. (Verifique a habilitação técnica de sua categoria antes da escolha do desbridamento). Considere esse instrumental contaminado após o uso;
- Se indicado, aplicar solução de limpeza apropriada com PHMB (polimixina B, hexamidina, etc), usando gaze estéril; deixar agir conforme orientação do fabricante (5 a 15 minutos). Depois da ação do PHMB, retira-se a gaze embebida de PHMB (não se deve mais usar SF 0,9%);
- Secar delicadamente a margem com gaze estéril, evitando fricção excessiva, no sentido do leito para a margem;
- Medir as dimensões da lesão (comprimento, largura e profundidade). Comprimento e largura medir com fita métrica ou **régua descartável de papel** ([clique no hiperlink e siga as orientações de impressão do documento](#)). A profundidade deve ser medida com auxílio de cateter estéril (ex.: cateter de aspiração ou cateter vesical);
- Realize a avaliação da ferida (medidas e fotografias). Recomenda-se fotografar após a limpeza, pois isso oferece uma visão completa da ferida (fotos antes e depois também podem ser feitas). Caso haja um segundo profissional disponível, ele pode realizar a fotografia. Se não houver, remova as luvas de procedimento e realize a higiene das mãos após medir a ferida.

6. Limpeza da área perilesional (20 cm da margem):

- Coloque gaze estéril umedecida com solução estéril (preferencialmente aquecida) sobre a ferida para proteção, antes de limpar e secar a pele ao redor da ferida;
- Limpar a área próxima à ferida e a pele ao redor com soro fisiológico, usando gaze para secagem;
- A seleção da cobertura deve ser feita de acordo com a avaliação da ferida realizada nos passos anteriores, considerando: Tipo de tecido predominante no leito da ferida; Quantidade de exsudato; Presença de infecção local; Características da pele perilesional; Local anatômico.

7. Aplicação da Cobertura:

- Aplicar a cobertura primária estéril diretamente sobre o leito da ferida, sem tocar diretamente com as mãos;
- Adicionar cobertura secundária, conforme necessário, para manter a proteção e absorção;
- Fixar o curativo adequadamente, utilizando: Fita microporosa, esparadrapo hipoalergênico, filme transparente, faixa de crepom, atadura ou roupas íntimas adaptadas, evitando tração sobre a pele;



- Marcar o curativo, quando oclusivo, com: Nome do profissional, data e hora do procedimento.

8. Finalizando o procedimento:

- Desprezar adequadamente os insumos utilizados conforme classificação de cada material;
- Proceder com a desinfecção do mobiliário e materiais utilizados;
- Proceder com a higienização das mãos por lavagem ou fricção conforme o material disponível no ambiente;
- Deixar o paciente confortável e em posição segura;
- Fornecer orientações sobre cuidados domiciliares, sinais de infecção e quando retornar;
- Agendar retorno, se necessário, conforme plano de cuidados ou prescrição profissional.

Passo 03. Orientações Gerais ao Paciente:

O profissional deverá orientar o paciente para:

- Observar sinais de complicações, como dor intensa, formigamento, inchaço excessivo ou alterações na coloração dos dedos, e reportar imediatamente à equipe de saúde;
- Retornar para reavaliação conforme agendamento ou se houver qualquer intercorrência.

Passo 04. Registro do Procedimento em prontuário eletrônico:

O profissional deverá realizar o registro em prontuário eletrônico e descrever as etapas e características a seguir:

- Informações fornecidas pelo usuário;
- Etiologia da lesão;
- Local da lesão e tipo de ferida;
- Dimensões da lesão (altura, largura, profundidade);
- Aspecto do leito (tipo de tecido, presença de esfacelo, necrose, granulação, hipergranulação);
- Condição da pele perilesional;
- Tipo de exsudato (seroso, purulento, hemorrágico), quantidade e odor;
- Solução utilizada para limpeza e cobertura aplicada;
- Técnica utilizada (jato, esfregaço, desbridamento);
- Reação do paciente ao procedimento, inclusive dor;
- Presença de sinais flogísticos (rubor, calor, dor, edema, perda de função);
- Evolução da lesão (quando houver);
- Observação do profissional;
- Prescrição de cuidados e coberturas;
- Cronograma de troca;



- Registrar código do procedimento conforme tabela SIGTAP (04.01.01.001-5 - curativo grau ii c/ ou s/ debridamento);
- Registrar código (CIAP/CID) conforme lesão;
- Orientações fornecidas ao paciente e ao acompanhante (anotar o nome e grau de parentesco);
- Adesão do paciente;
- Agendar retorno.

Sugerimos o modelo SOAP que é um acrônimo para um método de registro clínico estruturado que organiza a documentação do paciente em quatro partes: Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano.

Observações:

- Evitar falar no momento da realização do procedimento e orientar o paciente para que faça o mesmo;
- A troca do curativo será prescrita de acordo com a avaliação diária da ferida;
- Proceder a desinfecção da maca, cadeira, mobiliário, bandeja, carrinho ou mesa auxiliar após a execução de cada curativo, com solução álcool 70%, e ou com solução desinfetante com ação bactericida, fungicida e virucida;
- Não usar transfix para irrigar;
- Manter o Soro Fisiológico 0,9 % dentro do frasco de origem, desprezando o restante em caso de sobra, portanto utilizar o menor frasco disponível.

Quadro 01. Visão geral das técnicas de limpeza de feridas.

Técnica	Quando usar	Considerações de uso
A irrigação deve ser realizada com SF 0,9%, morna (para não retardar o processo de cicatrização), utilizando seringa de 20ml e agulha 40x12 (a pressão exercida no leito da lesão não deve ultrapassar 15 PSI por polegada quadrada, a fim de preservar os neotecidos formados)	Feridas com exsudato mínimo; Feridas sem esfacelo; Feridas com carga microbiana mínima.	Quando realizado em pressões mais altas, esteja ciente do risco ambiental contaminação por respingos ou aerossolização; Os possíveis efeitos adversos incluem: edema localizado no tecido/leito da ferida; potencial de propagação de bactérias mais profundamente nos tecidos da ferida; resfriamento do leito da ferida; embora a dor seja relatada, ela pode ser menor do que com outras técnicas, como esfregaço de feridas.
Esfregaço leve a moderado com gaze umedecida em movimentos circulares + Jato de de soro fisiológico 0,9% a uma distância de aproximadamente 15 cm.	Feridas com exsudato, detritos visíveis, descamação e outros tecidos não viáveis; Feridas com sinais e sintomas de infecção.	Pode redistribuir bactérias dentro do leito da ferida ou espalhar contaminantes da peri-ferida para o leito da ferida; Pode danificar o tecido de granulação recente; Implementar estratégias de controle de infecções; Não reutilize gaze em outro ponto da lesão; Não use a mesma gaze para limpar a pele circundante e o leito da lesão.

Fonte: International Wound Infection Institute (IWII) Therapeutic wound and skin cleansing: Clinical evidence and recommendations. Wounds International. 2025. Traduzido e adaptado por Mayra Helena Kock.



REFERÊNCIAS

POTTER, P.A; PERRY, A.G. FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM. Tradução SALLES, Adilson Dias, et al. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Prefeitura Municipal de Criciúma, 2021. Todos os direitos reservados à Prefeitura Municipal de Criciúma. www.criciuma.sc.gov.br. Material produzido pela Equipe Técnica/Criciúma em parceria com Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva [Mestrado Profissional], da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro Guia de boas práticas: sala de curativos / Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. - Rio de Janeiro, RJ: Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2023.

São Paulo (Cidade). Secretaria da Saúde. Manual técnico: normatização das rotinas e procedimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde / Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção Básica. 2. ed. - São Paulo: SMS, 2016. 292 p. – (Série Enfermagem)

BORGES, E.L; LIMA, V.L.A.N. Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Rubio, 2024. 400 p.

International Wound Infection Institute (IWII) Therapeutic wound and skin cleansing: Clinical evidence and recommendations. Wounds International. 2025.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 Coordenação ESF Mayra Helena Kock.	2025 Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos Nicole Schulka. Unidade de Saúde Digital Deisy Pereira Navarro Lins; Caroline Dias.	2025 Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos Cibely Schipitoski. Gerência da Qualidade e Desenvolvimento Institucional Juliana Antunes Safanelli.

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 25.0.244782-2
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde